

Checkpoint 1 — Entender, Planejar e Fundamental

Desafio 19 — Burnout Médico · Equipe Zelo · Prazo: 08/07/2026, 23h59 · 1ª Jornada Incubintech

1. Reformulação do problema

Hoje, um médico que começa a sentir sinais de esgotamento como insônia, irritabilidade, vontade de desistir, etc, não tem para onde ir. Os canais de saúde ocupacional que existem passam pelo RH ou pela própria hierarquia hospitalar, e isso já é suficiente para que ele prefira se automedicar ou continuar trabalhando exausto.

Entrevistamos um gestor médico de pronto-socorro e UTI, e ele resumiu a saúde mental da própria equipe como “frágil e subestimada”: frágil pela pressão constante do plantão, subestimada porque quem está na alta gestão não enxerga essa pressão de perto. Ele também confirmou algo que o briefing já apontava, agora com um rosto real: procurar ajuda psicológica é visto, no meio médico, como abrir mão de carga de trabalho, o que pesa contra a cultura de que “ser médico é dar conta de tudo”.

Esse problema afeta principalmente plantonistas de urgência, residentes, médicas mulheres e profissionais que tomam decisões de vida ou morte várias vezes por semana. Em números: mais da metade dos médicos brasileiros relata sintomas de burnout, mas menos de 1 em cada 8 busca ajuda profissional e a taxa de suicídio da categoria é mais que o dobro da população geral.

Isso importa porque cada médico que segue trabalhando exausto, sem qualquer canal seguro, é um risco não só para si, mas para os pacientes que atende sob fadiga extrema e um custo real para hospitais e cooperativas, que arcam com afastamentos, rotatividade e processos evitáveis quando esse sofrimento não é endereçado a tempo.

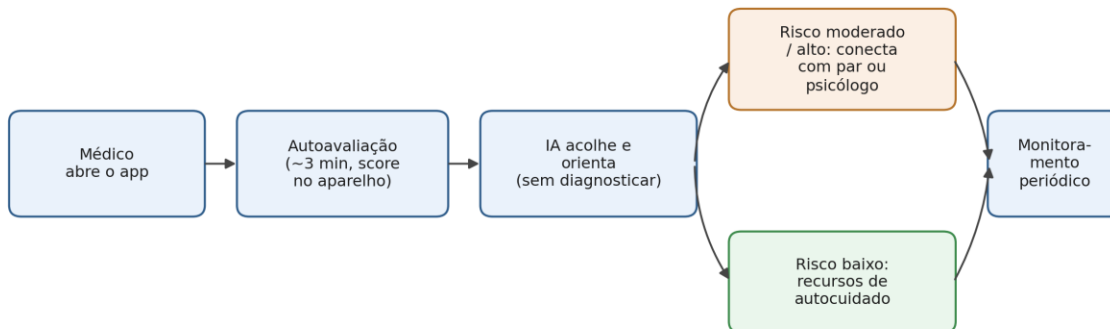
2. Visão geral da solução

Estamos construindo o Zelo, uma plataforma confidencial de triagem e apoio à saúde mental do médico, pensada para caber nos poucos minutos livres que ele tem entre um plantão e outro.

O médico abre o app e faz uma autoavaliação curta (cerca de 3 minutos), usando escalas clínicas reconhecidas (PHQ-9, GAD-7 e MBI-HSS), as mesmas que ele já conhece da própria formação. A diferença central é que o cálculo do resultado acontece no aparelho dele, não em um servidor: nenhuma resposta sensível sai do celular em texto legível antes de ser cifrada.

A partir desse resultado, ele é recebido por um chat de acolhimento com inteligência artificial. Esse chat escuta, valida o que ele está sentindo e reconhece o contexto da profissão (plantão, óbito de paciente, erro clínico, pressão hierárquica), mas nunca diagnostica, nunca prescreve e nunca se apresenta como substituto de um profissional de saúde mental. Se o padrão de respostas indicar risco moderado ou alto, o app oferece, nunca impõe, uma conexão anônima com um par médico treinado ou com um psicólogo parceiro. O médico acompanha sua evolução ao longo do tempo em um gráfico simples e privado e tem acesso a uma biblioteca de conteúdo sobre temas que ninguém mais fala abertamente na medicina: luto pelo paciente, erro clínico, sobrecarga do plantão. O hospital ou cooperativa que paga pela ferramenta enxerga apenas números agregados da equipe, nunca o dado de um médico específico.

O diferencial da nossa abordagem está focado na privacidade como uma decisão arquitetural e não é apenas uma promessa de marketing: o dado sensível nunca sai do dispositivo do médico em texto legível, e isso pode ser demonstrado tecnicamente, não apenas declarado. É esse tipo de prova que constrói a confiança que falta hoje entre o médico e qualquer canal institucional de cuidado.



Fluxo principal: médico abre o app → autoavaliação (score no aparelho) → IA acolhe e orienta → conforme o risco, conecta com par/psicólogo ou oferece autocuidado → monitoramento periódico.

3. Prova de conceito (PoC) realista

Na apresentação final do dia 25/07, vamos mostrar um protótipo funcional (TRL3) rodando como PWA no celular, com o seguinte fluxo ao vivo: autoavaliação com score calculado no próprio aparelho, chat de acolhimento por IA respondendo sem diagnosticar, e o caminho de escalonamento em crise, tanto o de aceite (conexão com um psicólogo, com token de sessão que não guarda a identidade em texto claro) quanto o de recusa (linha de crise exibida na hora). Vamos demonstrar também o matching anônimo de pares e um painel institucional com métricas agregadas e fictícias, mostrando como o hospital veria os dados sem nunca identificar um médico específico.

A demonstração será ao vivo, com dados fictícios preenchidos na hora, para provar que o app funciona de ponta a ponta e não é uma simulação gravada.

Sendo honestos sobre os limites: não temos psicólogos parceiros reais confirmados até o momento, então esse trecho do fluxo será simulado e diremos isso claramente durante a apresentação. O matching de pares também vai rodar com perfis simulados, não com uma base real de médicos cadastrados. Validação clínica formal (comitê de ética) e integração com sistemas hospitalares existentes ficam fora do escopo destes 28 dias, são passos de pré-incubação, não deste protótipo. Também não teremos app nativo nas lojas, apenas a versão PWA instalável. O foco dos próximos 18 dias é provar que a arquitetura de privacidade funciona de verdade (cálculo local, cifragem antes do envio, nenhum dado identificável no servidor) porque é esse o ponto que sustenta toda a proposta de confiança do produto.

4. Composição da equipe

Nome completo	Papel na equipe	Principais habilidades	Por que é o(a) mais capacitado(a)	LinkedIn	Instagram
Maurício Alexandre Barroso	Tech Lead / Desenvolvedor Full Stack	Arquitetura de software, React, Node, Docker, liderança técnica	Lidera a arquitetura de privacidade do produto (score client-side, cifragem) e integra todos os componentes técnicos, unindo visão de sistema com capacidade de liderar o time.	https://www.linkedin.com/in/mauricioab-dev/	@mauricio_alexandre

Nome completo	Papel na equipe	Principais habilidades	Por que é o(a) mais capacitado(a)	LinkedIn	Instagram
Katieli Bianca Dieter	Data Analytics — Sênior	Modelagem de dados, domain expert em análise, liderança	Referência técnica sênior em dados; responsável pela estimativa de impacto e pelo modelo de sustentabilidade, dois dos critérios de maior peso na avaliação do edital.	https://www.linkedin.com/in/katieli-dieter/	-
Yasmine Lisboa Bernardo	Data Analytics — Júnior	Análise de dados, proatividade, engajamento	Apoia a construção dos datasets simulados e das visualizações que sustentam o painel institucional e a demonstração de impacto.	https://www.linkedin.com/in/yasmine-lisboa-bernardo-165b59102/	https://www.instagram.com/minelisboa
Raquel Ritter Ribeiro	Marketing / Social Media	Comunicação, visão de negócio, copywriting	Conduziu a primeira entrevista de validação com usuário do projeto e traduz pesquisa e dados em uma narrativa clara para a banca avaliadora.	https://www.linkedin.com/in/raquelritter/	https://www.instagram.com/cafecomcr
Guilherme Barreto Gomes	DevOps	Infraestrutura, domain expert, dedicação	Garante que a arquitetura de privacidade declarada no papel se sustente em produção — infraestrutura segura, gestão de segredos e disponibilidade da demo.	https://www.linkedin.com/in/guilherme-barretog	-

Campos de LinkedIn e Instagram marcados como [preencher] precisam ser completados antes do envio — são obrigatórios pelo checkpoint.

5. Termo de compromisso

Responsável pela assinatura: Maurício Alexandre Barroso (líder de equipe).

Ação pendente: acessar <https://tech.floripa.br/termo-de-compromisso/>, ler o documento, assinar digitalmente via Gov.br (nível prata ou ouro) e anexar o PDF assinado junto com este documento no momento do envio. Sem o termo assinado, a equipe não prossegue para o próximo checkpoint.